

Protocolo de Crisis durante el Evento

Tipos de crisis · roles · pasos · frases ancla

AMARTE BE ON

Plan de Marketing y Operaciones · Mayo 2026

Audiencia: Los 3 facilitadores + persona de logística

Índice

01	Por qué este documento existe
02	4 tipos de crisis posibles
03	Roles del equipo durante crisis
04	Protocolo paso a paso · 8 pasos
05	Frases ancla y frases prohibidas
06	Botiquín y materiales requeridos
07	Documentación post-incidente
08	Tareas y deadlines del protocolo

01 · Por qué este documento existe

Breathwork intenso + 40 personas + 8 horas = estadísticamente alguien va a tener una respuesta fuerte. Esto es lo que separa a operadores serios de improvisados.

AMARTE BE ON trabaja con respiración consciente, frecuencias y comunidad. Estas herramientas son potentes — y eso significa que pueden hacer emerger emociones, recuerdos o sensaciones físicas inesperadas. **No es un riesgo: es parte del proceso.** Lo que sí es riesgo es no estar preparados.

“Si alguien tiene una respuesta fuerte y el equipo no sabe qué hacer, ese momento define cómo se cuenta el evento durante años.”

02 · 4 tipos de crisis posibles

Abreacción emocional intensa

Llanto incontrolable, pánico, recuerdo traumático que emerge, disociación.

Probabilidad estimada: ALTA (≥ 1 caso en evento de 40 personas con breathwork de 90 min)

Señales tempranas:

- Respiración acelerada o paralizada
 - Llanto fuerte o gritos
 - Cuerpo tembloroso o rígido
 - Mirada perdida (disociación)
 - Verbalización de pánico ('me estoy muriendo', 'no puedo respirar')
-

Episodio médico (no emocional)

Mareo severo, hiperventilación con pérdida de conciencia, ataque de ansiedad con síntomas físicos, lipotimia.

Probabilidad estimada: MEDIA (1 cada 5-10 eventos)

Señales tempranas:

- Palidez extrema o sudoración fría
 - Pérdida de equilibrio
 - Hormigueo en extremidades sostenido
 - Mareo que no cede al detener el ejercicio
-

Crisis de pareja / conflicto interpersonal

Dos asistentes que vinieron juntos entran en conflicto durante o después de un ejercicio.

Probabilidad estimada: BAJA (1 cada 8-10 eventos)

Señales tempranas:

- Voces alzadas en la sala o en pausa
 - Una persona sale del salón visiblemente alterada
 - Lenguaje corporal de tensión sostenida
-

Crisis técnica del evento

Corte de luz, falla de audio, problema con el salón, lluvia intensa que afecta llegada.

Probabilidad estimada: MEDIA

Señales tempranas:

- Sistema de audio comienza a fallar
 - Luz parpadea
 - Llegan llamadas de asistentes con problema de transporte
-

03 · Roles del equipo durante crisis

Antes del evento: en junta del equipo se asigna quién toma cada rol. **Durante el evento:** ante una crisis, los roles se activan automáticamente — sin discutir.

Rol	Quién	Qué hace
Primer respondiente	Facilitador más cercano físicamente al participante en crisis.	Acercarse con calma. Hacer contacto visual. Tono bajo. Frase ancla: 'Estás aquí. Estoy contigo. Vamos despacio.' NO tocar sin permiso. Llevar a espacio aparte si es seguro mover.
Apoyo emocional	Segundo facilitador asignado al rol del día (rotativo).	Acompaña al primer respondiente al espacio aparte. Hace contención mientras grupo continúa. Si la crisis es médica, llama al servicio de emergencia.
Continuador del grupo	El facilitador restante.	Mantiene el grupo en su ejercicio. Modera la energía. Hace transición suave a un ejercicio más bajo (respiración consciente sin breathwork intenso) hasta que la situación se resuelva.
Logística / contacto externo	Persona de logística del día.	Si se requiere ambulancia o salir del salón: llama al 911 (Ecuador) o ECU 911. Trae botiquín. Coordina con familia si la persona pidió contacto.

[TBD EN JUNTA] Asignar nombres específicos a cada rol antes del lanzamiento. Estos roles deben quedar memorizados por los 3.

04 · Protocolo paso a paso · 8 pasos

Paso 1.

DETECCIÓN — Cualquier facilitador o asistente reporta señal temprana al primer respondiente más cercano.

Paso 2.

CONTACTO INICIAL (30 seg) — Primer respondiente se acerca con calma, hace contacto visual, dice frase ancla. Evalúa: ¿persona consciente? ¿respira? ¿puede moverse?

Paso 3.

DECISIÓN (30 seg) — ¿Crisis emocional o médica? ¿Permanece en grupo o sale al espacio aparte?

Paso 4.

MOVILIZACIÓN — Si sale: primer respondiente + apoyo emocional acompañan al espacio aparte (idealmente con manta + agua).

Paso 5.

CONTENCIÓN (5-15 min) — Espacio seguro, voz baja, NO interpretar ni interrogar. Dejar que la persona regule respiración. Frase ancla: 'Lo que sentiste tiene sentido. Estás a salvo. Vamos a respirar juntos.'

Paso 6.

REGULACIÓN (15-30 min) — Cuando hay base, ofrecer agua, manta, una galleta. Conversar suavemente. Escuchar sin proponer.

Paso 7.

REINTEGRACIÓN O DESPEDIDA — Cuando la persona está estable: ¿quiere volver al grupo, observar desde un costado, o irse a casa? Respetar 100% lo que pida.

Paso 8.

CIERRE Y SEGUIMIENTO — Antes de irse: contacto post-evento (24h, 72h, 7 días). Si fue médico: documentación + comunicación con familia si la persona lo autorizó.

05 · Frases ancla y frases prohibidas

■ Frases ancla — usar libremente

- *"Estás aquí. Estoy contigo."*
- *"Lo que sientes tiene sentido."*
- *"No tienes que hablar. Solo respirar."*
- *"Vamos a movernos despacio."*
- *"Pon una mano en tu pecho. Siente cómo sube y baja."*
- *"Mira algo en la sala que te dé seguridad. Quédate ahí 30 segundos."*
- *"Tu cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer. Lo dejas pasar."*
- *"Cuando estés lista/o, abrimos los ojos juntos."*

■ Frases PROHIBIDAS — nunca usar

- *"Tranquilízate / cálmate"*
- *"No es para tanto"*
- *"Estás siendo dramático/a"*
- *"Eso ya pasó (cuando emerge un trauma)"*
- *"Respira hondo (sin guía concreta)"*
- *"Todos pasamos por eso"*

Por qué importa: 'tranquilízate' es la frase que más activa a alguien en crisis. Lo que regula es la presencia, no las palabras. Quédate en silencio si no sabes qué decir — eso ya es suficiente.

06 · Botiquín y materiales requeridos

Material	Detalle	
Botiquín médico básico	Vendas, gasas, alcohol, paracetamol, ibuprofeno, antiácido, banditas adhesivas, suero oral	■
Bolsa de papel	Para hiperventilación · sirve para reinarhalar CO2 si se valida con la persona	■
Mantas térmicas (3-4)	Sensación de seguridad + regulación corporal post abreacción	■
Agua + electrolitos	Para reposo / recuperación	■
Galletas / fruta seca	Glucosa rápida si hay lipotimia	■
Espacio aparte preparado	Cuarto/zona del salón con cojines, baja luz, fuera de vista del grupo principal	■
Lista de contactos emergencia	ECU 911 (Ecuador) · Hospital más cercano · familiares de cada asistente (recoger en formulario inscripción)	■
Formulario de incidente	Para documentar qué pasó, quién intervino, qué se hizo. Para mejora interna y respaldo legal.	■

07 · Documentación post-incidente

Cualquier evento crítico debe documentarse. No por miedo legal — por **aprendizaje sistemático del equipo**.

Plantilla de Reporte de Incidente

- Fecha y hora: _____
- Tipo: [Emocional / Médica / Conflicto / Técnica] _____
- Persona involucrada (iniciales): _____
- Bloque del evento en que ocurrió: _____
- Señales tempranas observadas: _____
- Quién detectó · quién intervino: _____
- Acciones tomadas (cronología): _____
- Resultado: [Reintegrada/o / Se retiró / Atención externa] _____
- Seguimiento (24h, 72h, 7 días): _____
- Aprendizaje para futuras ediciones: _____

■ Tareas y deadlines del protocolo

Tarea	Responsable sugerido	Deadline
■ Lectura conjunta y simulacro del protocolo · los 3 facilitadores	Equipo (los 3)	Sábado 6 jun
■ Asignar roles específicos del protocolo (primer respondiente, apoyo, continuador, logística)	Equipo (los 3)	Sábado 6 jun
■ Conseguir botiquín médico básico + bolsa papel + mantas térmicas	Logística	Jueves 11 jun
■ Preparar 'espacio aparte' en el salón — ubicar exactamente dónde	Logística + Miguel	Viernes 12 jun
■ Lista de contactos de emergencia · ECU 911, hospital cercano, contacto familiar	Logística	Lunes 1 jun
■ Práctica con simulacro de abreacción — los 3 facilitadores	Equipo (los 3)	Domingo 7 jun
■ Identificar psicólogo de respaldo en Quito para crisis grave	[TBD junta]	Domingo 1 jun

Las tareas son sugerencias del plan. La asignación final de responsables se decide en junta del equipo.

Antes del evento, validar que el equipo:

- Conoce de memoria los 8 pasos del protocolo.
- Sabe cuál es el rol que le toca y qué hace exactamente.
- Ha practicado las frases ancla en voz alta.
- Tiene acceso al botiquín y sabe dónde está el espacio aparte.
- Tiene en el celular los números de emergencia.